ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

RELACIÓN ENTRE LA VELOCIDAD DE LA MARCHA Y EL RIESGO DE CAÍDAS EN ADULTOS MAYORES: REVISIÓN DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

Estudiantes: Función musculoesquelética y tegumentaria | Docente: Lida María Castillo
Curso: 4D | Semestre: Cuarto

Introducción

Las caídas representan un problema prioritario de salud publica en adultos mayores, con una prevalencia cercana al 30% anual en mayores de 65 años, generando hospitalizaciones, discapacidad y pérdida de independencia.

La velocidad de la marcha es un indicador funcional clave (sexto signo vital")accesible y de bajo costo en fisioterapia para detectar tempranamente fragilidad y el riesgo de caídas.

Planteamiento del problema

Aunque una velocidad de marcha reducida (<0.8 m/s o <1.0 m/s) se asocia con mayor riesgo de caídas, su capacidad predictiva aislada varía según el contexto clínico, el deterioro cognitivo, el miedo a caer y la velocidad de deterioro anual (20.10 m/s al año).

Es necesario sistematizar los hallazgos recientes para orientar la valoración fisioterapéutica integral.

Metodología

Revisión documental y síntesis de 24 artículos científicos y revisiones (2009-2026) extraídos de bases de datos como PubMed/PMC, ScienceDirect, Springer Nature, SciELO y MDPI. Se analizaron diseños longitudinales de cohorte, transversales, revisiones sistemáticas, metaanálisis IPD y revisiones paraguas sobre velocidad de marcha, parámetros espaciotemporales y riesgo de caídas en adultos mayores.

Resultados

HALLAZGOS PRINCIPALES

ESTUDIO (AUTOR & AÑO)	MÉTRICA / VALOR DE VELOCIDAD	RESULTADO / IMPLICACIÓN
Hicks et al. (2026)	< 1,0 m/s	Punto de corte preventivo.
Adam et al. (2023)	Deterioro ≥ 0,10 m/s en 12 meses	Asociado con 13 % más riesgo y 44 % más caídas recurrentes.
Quach et al. (2011)	< 0,6 m/s y > 1,3 m/s (Relación en U)	< 0,6 m/s elevó las caídas en interiores (IRR 2,17) y > 1,3 m/s las exteriores (IRR 2,11).
Egan et al. (2021)	Aumento de 10 cm/s	Redujo 5 % el riesgo (RR 0,95).
Hicks et al. (2026)	Comparativa de grupos	Se reportaron diferencias de caídas recurrentes (35 % vs. 15 %).

Fuente: Resumen de Estudios

Discusión

La evidencia confirma que tanto una velocidad basal baja como su disminución progresiva predicen caídas en adultos mayores con y sin deterioro cognitivo leve (Satis Kayahan et al., 2024; Adam et al..

Sin embargo, revisiones paraguas (Beck Jepsen et al., 2022) señalan que ninguna prueba aislada basta por sí sola; factores como la fuerza de prensión (Pham et al., 2023), la confianza en el equilibrio (Tsang et al., 2023) y la variabilidad del paso modulan este riesgo.

Conclusión

La velocidad de la marcha es una herramienta clínica válida, rápida y económica para el tamizaje fisioterapéutico del riesgo de caídas en adultos mayores. Se recomienda adoptar el punto de corte <1.0 m/s y monitorear cambios longitudinales dentro de una valoración multifactorial que integre equilibrio, fuerza muscular y cognición.

REFERENCIAS CLAVE (QR)

3 SALUD Y BIENESTAR